

交通事故完整经过说明（供受托律师阅卷）

青岛市市北区抚顺路和哈尔滨路路口 · 货运三轮 × 美团女骑手 · 截至 2026-08-19

本文仅供受托律师了解案情、查看监控和决定程序。不是律师函，不要发给骑手、站点、保险公司或刘孝春。现阶段不请诉讼律师当面谈、不先发函。

请律师先做这几件事

- 请先调看或复制市北区交警已调取的事故监控，再决定走简易程序还是一般程序。家属不自己拍板。
- 同意任何责任比例或在认定书上签字前，请书面或微信给出意见。
- 请评估一般程序可能带来的无牌上路风险。驾驶人有驾驶资格证书，内部留复印件；不要主动把驾驶证交给一般程序扩查。
- 请指导固定用工证据和 3 万元垫付收据的性质表述。现在不必发函。触发条件见文末。
- 现阶段请不要对外报总赔偿数额或残级。

一、文书性质

本稿根据 2026 年 8 月 14 日至 19 日就医记录、齐鲁医院已审核云影像三份 CT、家属提交的《胡志远病例文件.pdf》（急诊病历、出院记录、腕带、处方）、市北区交警口头说明，以及伤者家属胡继刚 8 月 19 日书面确认的待确认事项整理。录音转写（得到大脑 17 份合集）只作内部线索，不等于事故认定书、病历、保险条款或鉴定意见。病历扫描件另做成图文摘录 Word/PDF，抽出腕带、急诊病历、出院记录、三份 CT 和破伤风处方，便于对照原件。

伤者病历姓名为胡志远。家属口头称老爷子，对外材料曾写胡某。用工老板转写曾作「刘小春」。对外法律文书一律以身份证、病历首页、微信实名为准。

二、当事人

伤者：胡志远，男，64 岁，已退休。齐鲁门诊号 0002750430，住院号 0001519455，11D 手足与显微重建外科 33 床。事发时受雇于乔刘记商贸，为刘孝春卸货搬运，驾驶/使用刘家货运三轮车。交警口头认定该三轮属机动车。仅有抚顺路批发市场内部牌，无青岛市机动车号牌。驾驶人具备驾驶资格证书。

家属对接人：胡继刚（儿子，自上海返回处理）。岳父为执业律师，目前仅场外把关，不到场、不署名发函。

对方：女性美团外卖骑手，驾驶黄色二轮电动自行车。交警称其配偶亦送外卖、育有两子，个人偿付能力有限。8 月 17 日约定加其 1866 开头微信，等保险客服。对方车辆无交强险、无商业三者险，理赔入口是美团平台险。

交警：青岛市市北区交警，对接人称陈师傅。双方车辆已扣至交警停车场。监控已调取。书面事故认定书截至 2026-08-19 尚未出具。

用工方：乔刘记商贸，负责人刘孝春。伤者事发时的雇佣老板，三轮车实际所有人或管理人。雇佣关系，未签劳动合同。已垫付现金 3 万元。

三、完整经过

2026年8月14日（周五），胡志远在青岛市市北区抚顺路和哈尔滨路路口（抚顺路批发市场）为刘孝春家卸货搬运。急诊病历就诊 12:27:11，主诉车祸伤致右踝疼痛肿胀 2 小时；入院记录 14:14，主诉 3 小时余。具体钟点以接处警记录和认定书为准。地点经家属确认：抚顺路和哈尔滨路路口。录音中其他市场别称一律停用，仍以认定书正式路名为准。

当日胡志远卸完第一趟货物后，驾驶该货运三轮回场装第二趟。车辆贴护栏上坡，准备左拐去下方装货，再往楼上运送。因护栏开口（家属 8 月 18 日称哈尔滨路一侧 1 号门出口斜坡护栏开口），须先向上、向右借道调整，再作大弧度左拐掉头。同日口述称双方当时都往上走，不是一对一下坡对冲；是否如此，以监控为准。该三轮左转向灯失灵，另有口述大灯亦坏。

掉头过程中，后方一辆黄色美团二轮电动自行车与三轮发生碰撞。三轮侧翻，脚踏板压在胡志远右脚上，致右下肢受伤。交警称监控视频能看清过程；家属称监控可能看不清护栏。护栏开口可以向交警说明掉头动作的来源，但不能据此主张对方全责。

伤者当日 12:27 至山东大学齐鲁医院（青岛）急诊骨科。门诊号 0002750430。生命体征：T 36.2，P 87 次/分，R 22 次/分，BP 175/80 mmHg，SpO2 96%。既往高血压、糖尿病，过敏史无。急诊初步诊断：车祸伤、右小腿外伤、右踝关节骨折伴脱位。医嘱破伤风人免疫球蛋白 250iu 肌注（270 元）及右小腿、右足 CT。手足外科赛佳明副主任医师会诊后建议手术并开具住院证。2026-08-14 已审核 CT（检查号 10008056847，13:02）记载：右侧胫骨远端、腓骨近端骨质不连续，断端移位；踝关节对位不良，胫距关节间隙增宽，构成半脱位；距骨内缘、外踝撕脱性骨折；右小腿及踝关节软组织肿胀。同日右足 CT（检查号 10008056848）记载右足组成骨完整、诸关节在位，未见本次外伤性骨折；跟骨骨刺、退变、第一跖骨头囊变属陈旧/退变，不计入本次事故。

2026-08-14 14:14 收入手足与显微重建外科 11D 病区 33 床，住院号 0001519455。入院查体：右踝明显肿胀畸形，内踝碾挫伤创面深达骨质、组织灰暗无血运，足背动脉搏动弱。同日 19:01 行右踝关节骨折脱位切开复位内外固定、韧带缝合、软组织清创、VSD 负压吸引。2026-08-15 16:26 术后 CT（检查号 10008059257，报告医师管帅）复查：内外固定在位，位线可，周围软组织仍肿。出院记录固定装置表述为外固定架及克氏针，未写锁定钉根数；完整手术记录和植入物编码仍要向病案室取。通话曾说「8 月 15 日已出院回家」或「打了两根/四根钢钉」，与病历不符。

8 月 15 日至 16 日，家属内部一度按「对方全责」沟通，并与骑手电话联系。骑手表示书面责任认定尚未出具，需等待交警调取监控并由公司、保险处理。家属要求建立多方微信群，对骑手未探望表示不满。早期「交警已定全责」的说法，已被 8 月 17 日交警根据监控作出的口头分析否定，不得再对外使用。

2026 年 8 月 17 日，市北区交警陈师傅根据监控向家属说明：任何一方全责均已排除；可能结果为双方同等责任，或外卖骑手主责、三轮次责。交警指出三轮一方问题包括：可能被认定机动车但无青岛市正式号牌、左转向灯失灵、掉头时先向右再向左形成大弧度。交警指出骑手一方问题包括：未与前车保持足够安全距离；处于后方、视野更清楚，有条件提前规避。交警介绍简易程序与一般程序，并曾建议优先协商走简易。交警明确其职责是认定事故责任，不负责决定赔偿金额；认定书出具后交警不再参与赔多少钱。两车已扣。监控已调取。书面认定书仍未出具。

同日，因齐鲁医院床位周转，院方将患者转至联合体公立二甲青岛市市北区人民医院（抚顺路院区）。出院记录载明 2026-08-17 08:00 出院，住院 3 天，出院时切口稍红肿、少量血性渗出，VSD 通畅，外固定架及克氏针可靠，医嘱继续负压吸引并根据创面二期治疗。转院前须先完成齐鲁出院结算，人民医院才能办理入院；结余去一楼收费窗口原路退。转院救护车实收 160

元，须发票。手术当夜至出院不到 3 天，不是康复期。主治赛佳明副主任医师态度强硬，明确不愿交交通事故患者长期占床。家属最关心的是二甲后续费用美团平台险是否认可。

8 月 17 日下午，骑手称已打保险客服、尚未回信，约定加 1866 开头微信。对方是外卖电动车，认定书上未必印传统车险公司电话。须向骑手、站点索取美团平台险承保公司、保单号、报案号、限额及书面赔付比例。

2026 年 8 月 19 日，家属书面确认：认定书尚未出具；地点为抚顺路和哈尔滨路路口（抚顺路批发市场）；驾驶人持有驾驶资格证书；平台是美团，保单待骑手拉群；市北区人民医院费用可以赔、比例待定，口径为二级以上公立医院、医保范围内用药可以；用工单位乔刘记商贸、负责人刘孝春、雇佣未签劳动合同、不具备工伤认定条件，已垫付现金 3 万元；费用口径另确认 4 万元，须用发票与 3 万垫付分清；简易或一般程序由律师看完监控和车辆材料后确定。

截至本稿，伤者人已到市北区人民医院。齐鲁住院号已有，人民医院住院号、齐鲁出院结算是否办完、保险书面比例，仍须核实。出院医嘱要求隔日换药、继续 VSD、避免负重。伤者目前不能下地、不能独自如厕，按不能自理处理，应请医院合作一对一 24 小时护工（合同加发票）。伤残鉴定尚未进行，现在不能报残级。病历复印须出院后 10 个工作日内至博施楼 1 楼服务中心，带患者身份证。

四、伤情（CT + 出院记录）

CT 计入本次事故：右侧胫骨远端骨折（移位）、右侧腓骨近端骨折（移位）、右踝关节半脱位、右距骨内缘撕脱性骨折、右外踝撕脱性骨折、右小腿及踝关节软组织肿胀。

出院记录比 CT 更重，必须一并采用：右开放性踝关节骨折、右开放性踝关节脱位、右踝部韧带断裂、右踝挫伤并皮肤坏死。入院查体内踝碾挫创面深达骨质、无血运。2026-08-14 19:01 已行切开复位内外固定、韧带缝合、清创及 VSD。高血压、糖尿病为既往病，不按事故伤索赔。

不计入本次事故：右足组成骨完整；跟骨骨刺、退变、第一跖骨头囊变。通话中「右脚后跟粉碎性骨折」「只是腓骨下段骨折」均与报告不符，对外必须改口。

云影像报告注明仅供临床医生参考、不作证明。CT 和出院记录都不是伤残鉴定书。评残须治疗终结后由有资质司法鉴定机构按道路交通事故标准（实务多用《人体损伤致残程度分级》）评定。不要用人社局工伤标准，不要按网上计算器报价。开放性损伤、韧带断裂、皮肤坏死和可能的二期治疗，只说明伤情重、疗程可能更长，现在仍不能报残级或总赔偿数额。

五、责任与程序现状

书面事故认定书尚未出具。交警依据监控排除任何一方全责。可能同等，或外卖主责、三轮次责。过错的规范表述以认定书为准。

交警认定通常只划分三轮使用人胡某与美团骑手之间的过错，不会把刘孝春写成替骑手担责。无牌、灯坏、掉头动作，仍可能记在三轮这一方。家属内部「驾驶人 0 责、刘孝春把 30% 全包」「骑手 70%、用工方 30%」仅为讨论，不是交警或法院结论。

简易程序不审车辆手续和驾驶资质，出认定书较快，便于保险理赔。一般程序可能扣车鉴定、审查号牌和驾驶资格，周期较长。无青岛市号牌在一般程序中仍有风险。驾驶人有证，无证驾驶风险已下降。程序选择请律师看监控和车辆后决定。

六、就医、保险与费用

首诊及手术在山东大学齐鲁医院（青岛）三甲。后转市北区人民医院（抚顺路院区）公立二甲。转院类沟通大量重复，核心只三点：先完成原医院结算；确认新医院能否正常入院；向实际承保公司书面确认二甲医院的赔付资格和比例。不要另找其他三甲碰运气。医保能报不等于美团险能报。口头「可以赔」不等于书面比例已定，不能按全额报销花钱。

平台是美团。承保公司、保单号、限额、书面赔付比例待骑手拉群确认。没有交强险，没有「先无责垫 1.8 万医疗」这一套。

费用：家属确认口径 4 万元，须发票逐笔核清，不能再对外报 3.5 万或 7 万。刘孝春垫付现金 3 万元是另一笔，须收据写明：垫付医疗费，不是借款，不是一次性了结交通事故，不冲抵未结工钱，不代美团赔偿。未结工钱口述约 5000 元，另写欠条，不乘责任比例。转院救护车 160 元须发票。病区串台出现的蒋玉年、26 床、8000 元不是本案。

七、用工关系

家属确认：雇佣关系，未签劳动合同，不具备工伤认定条件。不要去人社局报工伤。核实用工关系、车辆归属、工资结算和事故当日工作任务，是为可能的工伤或用工责任留证，不是现在启动工伤认定。

雇员受害仍可主张，不必等法院先确认雇佣或劳务法律关系。有乔刘记商贸派活、车是刘的、人在卸货、有工钱或欠薪，即可考虑民法典第 1192 条（个人劳务）和第 1209 条（转让、交付机动车的所有人、管理人过错）。刘孝春没有义务承担美团骑手责任范围内赔不够的部分；可主张的是己方缺口里与其车主过错、接受劳务过错相当的部分。未结工钱 100% 由刘支付。

八、请律师重点审查

第一，监控：事故编号、调取回执、律师查看或复制的时间。护栏开口在画面中是否可辨。两车速度、跟车距离、转向灯是否点亮。

第二，程序：看完监控和内部牌、灯坏情况后，明确建议简易或一般。无牌风险是否大到必须回避一般程序。

第三，认定书：预计出具日；收到后核实地名、身份、过错描述、责任比例。不服则指导复核，不要当场情绪化拒签。

第四，保险：指导如何向骑手、站点书面要保单和人民医院赔付比例，避免只打口头电话。

第五，用工书面：3 万收据和 5000 欠条的表述。现在不发律师函。触发后再议：超过 3 天无保险对接人；保险拒赔或书面不认必要医院又拒绝协调；骑手失联并拒绝拉群；有人逼签总包或放弃评残；认定书后 15 天无实质进展；需要评残或起诉。

九、不得写入对外函件或向对方陈述的内容

不要写对方全责、已经几级伤残、右脚后跟粉碎性骨折、已经康复、总赔偿数额或一次性了结。

不要写叉车、孙总是老板、驾驶人个人 0 责、刘孝春替美团补 70%。不要把记录 16 远洋工伤九级、25 万至 30 万当成本案。不要把 3D 示范动画当证据。

现阶段不谈总赔偿数额。费用还在发生，等认定书和治疗稳定、鉴定条件成熟后再按票计算交通事故赔偿，以及雇员受害、车主过错请求。

十、现有材料与仍缺文件

已经可以交给律师的：

- 齐鲁医院《胡志远病例文件》：急诊病历、出院记录、腕带、破伤风处方、三份 CT 纸质报告
- 病历图文摘录 Word/PDF：从扫描件抽出腕带、急诊病历、出院记录、三份 CT、破伤风处方（不是律师函）
- 齐鲁医院云影像三份已审核 CT（10008056847 右小腿、10008056848 右足、10008059257 术后右踝）
- 沟通记录合集（2026-08-15 至 18 日，17 份转写）及口径对照
- 家属 2026-08-19 对 14 条待确认事项的书面答复
- 交警口头：监控已调、两车已扣、排除全责；书面认定书未出

请指导家属尽快补齐的：

- 事故编号、监控调取/查看回执或复制件
- 书面事故认定书（预计出具日）
- 人民医院住院号；齐鲁出院结算票据
- 完整手术记录、麻醉记录、植入物编码（出院记录已有术式，仍缺根数/编码）
- 美团平台险：承保公司、保单号、报案号、限额、人民医院书面赔付比例
- 费用发票台账（核清 4 万元），与刘孝春垫付 3 万元收据分清
- 3 万元垫付收据（性质：垫付不是借款、不是了结）及约 5000 元欠薪书面
- 内部牌、转向灯损坏、护栏开口现场照片；驾驶证复印件仅内部留存
- 护工一对一 24 小时合同及发票

本文根据 2026 年 8 月 14-19 日材料整理。重新生成：python3 scripts/build_all.py。3D 示范动画留作待用，不是证据。